Instrumento en Terapia Física

Marcha Patológica

Semana 19

Presente.

Saberes previos :

De acuerdo a esta imágen ¿a qué llamamos marcha patológica?

Observa el video

https://youtu.be/zvn52X5AEec

Después de visualizar el video, responde a las siguientes preguntas a través de una herramienta digital

¿Qué es una marcha neurológica?

¿Cómo es la marcha en un paciente con pci?

Logro:

Al finalizar la sesión, el estudiante describe las marchas patológicas, mediante la elaboración de un video.

Temario:

Marcha patológica

1. Definición
2. Características
3. Grados
4. Diagnóstico
5. Evaluación

1.DEFINICIÓN

Se refiere a cualquier alteración de la marcha debida al dolor. El término marcha antiálgica es inespecífico. Diferentes patologías pueden provocar compensaciones durante la marcha similares

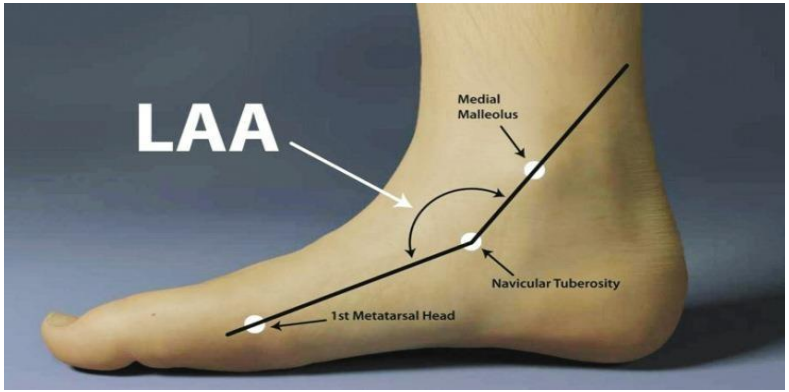
2. CARACTERÍSTICAS

Se refiere a cualquier alteración de la **marcha** debida al dolor. El término **marcha** antiálgica es inespecífico. Diferentes patologías pueden provocar compensaciones durante la **marcha** similares.

3. GRADOS

Es el ángulo formado entre el maléolo medial (o tibial), la cabeza del primer metatarsiano y el navicular, el cual representa el arquetipo medial del pie.
Originalmente Dahle estableció la normalidad entre 120º y 150º (y los extremos en 90º y 180º), pero posteriormente Nilsson utilizó una muestra mayor, estableciendo los siguientes rangos angulares, los cuales recomendamos:

Plano extremo: menos de 121º
Plano: 121º-130º
Normal: 131º-152º
Cavo: 153º-162º
Cavo extremo: más de 162º



4. DIAGNÓSTICO

El diagnóstico del tipo de marcha se realiza simplemente con la exploración física. La valoración de los antecedentes (historia clínica), junto con los estudios neurorradiológicos sirven para determinar la etiología y establecer la morfología de la lesión cerebral subyacente.

5. EVALUACIÓN

El andar puede evaluarse en una cinta rodante u otros dispositivos con control de tiempo. Las características a analizar incluyen la velocidad, la cadencia (pasos por minuto), los tiempos de apoyo y oscilación y los intervalos de apoyo unipodal y bipodal.

La **marcha senil** se caracteriza por una postura del cuerpo con discreta proyección anterior de cabeza, flexión del tronco, caderas y rodillas. Las extremidades superiores tienden a realizar un menor balanceo y el desplazamiento vertical del tronco se reduce.

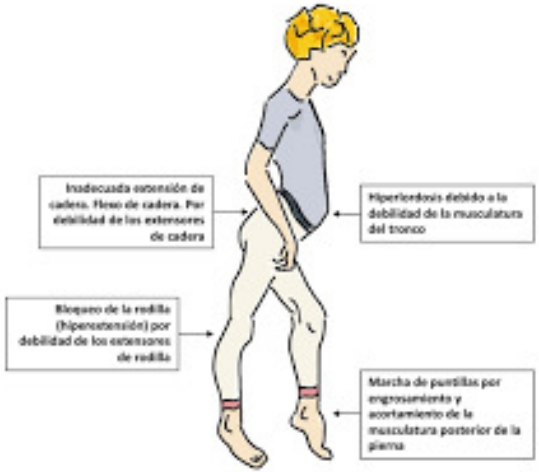
Marcha parkinsoniana: disminución del braceo, flexión postural, bradicinesia, congelamiento (dificultad al inicio de la **marcha**), pasos cortos, festinación (o aceleración del paso), giros en bloque, sin aumento de base de sustentación.

Las personas con **apraxia** de la **marcha** no pueden procesar los impulsos nerviosos para realizar actividades de forma correcta, incluso aunque la fuerza y sensibilidad sean adecuadas. La alteración de la **marcha** en la vejez es una forma moderada de **apraxia** frontal.

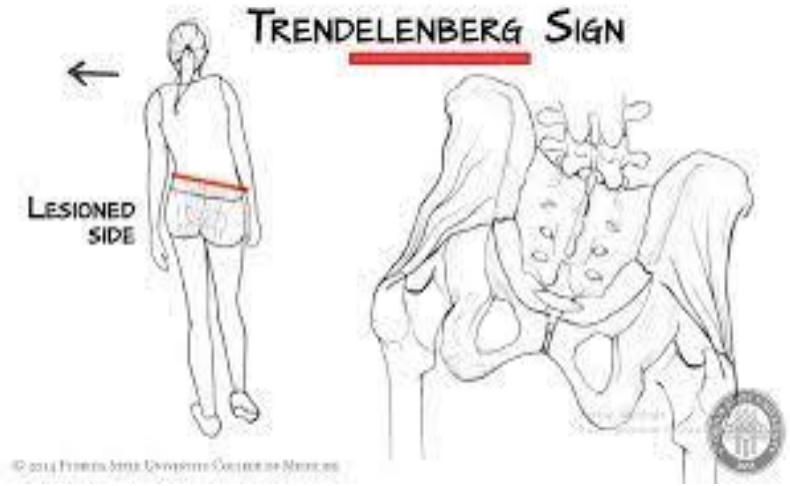
Revista Médica Clínica Las Condes. 2014;25:265–75

Marcha vestibular, en «estrella» o «brújula». Los pacientes que presentan esta alteración de la **marcha**, cuando se les pide que caminen unos pasos hacia delante y los mismos hacia atrás, van produciendo una desviación angular que será izquierda o derecha en dependencia de la localización de la lesión.

Forma de **marcha anormal** caracterizada por la realización de movimientos laterales del tronco exagerados, acompañados de elevación de la cadera. También es conocida por los siguientes términos: Marcha anadeante, Marcha de ánade, Marcha de pingüino, Marcha de pato, Marcha distrófica.

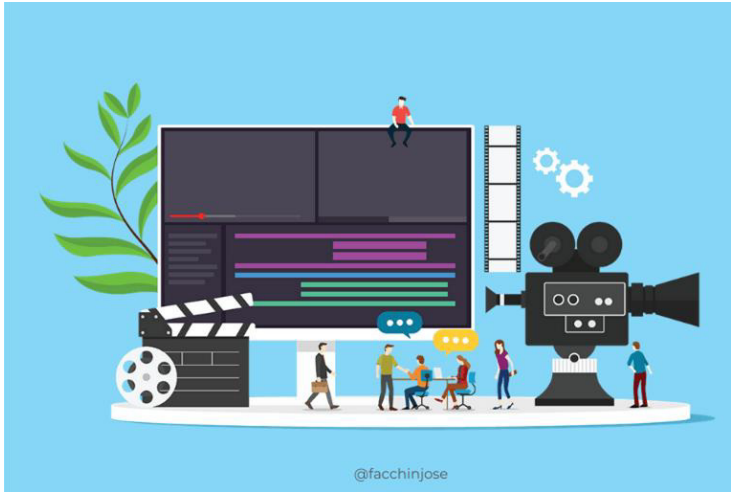


La **marcha** de **Trendelenburg** es la marcha claudicante de los pacientes con mala función de los músculos abductores de la cadera. Es muy frecuente en niños con luxación congénita de cadera, pero es menos frecuente en adultos.



Actividad:

Elaborar un video de la marcha patológica e identificar sus tipos y tratamientos de rehabilitación.



Conclusiones

Aportes

La marcha patológica, se da por una complicación que puede llegar por otros orígenes.

Aportes

La forma de diagnosticar se da por la valoración de la marcha.

Aportes

Los problemas neurológicos, pueden crear una marcha patologica

Metacognición

¿Qué aprendí hoy?

¿En qué situaciones podré aplicar lo aprendido hoy?

Referencias

1. Goic G. A; Chamorro Z. *Semiología médica*. 2a ed. Santiago de Chile: Mediterráneo; 1999.
   UBICACIÓN: Biblioteca Av. Arequipa 351. (Sede 7818).
   CODIGO: C/616.0754/GOIC

2. martinez carla. tipos de pie [Internet]. 2022 [citado 1 mayo 2022]. Disponible en: https://www.mundodeportivo.com/uncomo/salud/articulo/tipos-de-pies-51805.html#:~:text=Tipos%20de%20pies-,Tipos%20de%20pies,-Por%20Carla%20Mart%C3%ADnez

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Muchas gracias

Presente.